PSYCHOMÉTRIE

UE B2 · SEMESTRE 1 · Nathalie Khatir · 2026

Ce que mesure la psychométrie · L'examen psychologique : objectifs et déroulement · Le tout-petit : développement psychomoteur · Échelles de Wechsler : du score au profil · Évaluer la personnalité et ses dimensions · Questionnaires, Beck et Conners · Neuropsychologie et MMSE · Pièges QCM · Définitions et mots-clés

01 · Ce que mesure la psychométrie

La psychométrie étudie la construction et l'utilisation des instruments qui évaluent les caractéristiques mentales : connaissances, personnalité, langage, intelligence, mémoire et autres fonctions cognitives. Elle associe une théorie de ce que l'on souhaite étudier à une méthode d'observation, de cotation et de comparaison.

Une caractéristique psychologique ne s'observe pas comme une longueur. On observe des réponses, des conduites ou des performances dans une situation définie, puis on les utilise comme indicateurs du fonctionnement recherché. Un score décrit ainsi une performance dans un cadre donné ; il n'épuise ni l'intelligence, ni la personnalité, ni l'histoire de la personne.

Standardiser et étalonner : deux opérations différentes

Notion	Principe	Ce que cela permet
Standardisation	Fixer les consignes, le matériel, l'ordre des épreuves, les conditions et la cotation.	Comparer des performances recueillies dans des conditions aussi semblables que possible.
Étalonnage	Construire des références à partir des résultats d'un groupe pertinent.	Situer le résultat individuel dans une population de référence.
Interprétation clinique	Relier les résultats à la demande, aux observations et à la situation de la personne.	Donner un sens au score sans réduire la personne à son classement.

Le groupe d'étalonnage doit correspondre au public pour lequel l'instrument est prévu. Comparer un enfant à des adultes, ou interpréter une épreuve langagière sans tenir compte de la langue comprise, ferait perdre son sens à la comparaison. Moyenne, écart-type et fréquence relative sont des repères de positionnement, et non des jugements de valeur.

Exemple de compréhension

Pour le QI, une moyenne de référence centrée sur 100 est évoquée en cours. Le point à comprendre est le positionnement relatif : le résultat s'interprète avec l'échelle, l'âge et le profil. Un chiffre isolé ne définit pas les possibilités de la personne.

Test psychométrique et examen clinique

Dans la définition présentée par Pichot en 1949, le test repose sur une situation expérimentale standardisée et sur une comparaison statistique avec d'autres personnes placées dans la même situation. Le classement peut être quantitatif, selon une valeur, ou typologique, selon un type de réponse. L'examen clinique est plus large : il explore une situation singulière et peut intégrer des tests sans se résumer à eux.

À retenir

Standardisé = conditions communes. Étalonné = références de comparaison. Interprété = résultat remis dans son contexte. Ces trois étapes sont complémentaires.

02 · Les trois qualités d'un instrument

Un questionnaire n'est pas un outil psychométrique fiable parce qu'il produit un nombre ou paraît sérieux. Le support retient trois qualités de validation : fidélité, validité et sensibilité. Elles répondent à trois questions différentes.

Qualité	Question à poser	Exemple pédagogique
Fidélité	La mesure est-elle suffisamment stable et reproductible lorsque le phénomène étudié reste comparable ?	Un instrument ne devrait pas donner des résultats très différents sans raison liée à la personne ou aux conditions.
Validité	Mesure-t-on bien le phénomène annoncé ?	Une échelle présentée comme une mesure de dépression ne doit pas essentiellement mesurer l'anxiété.
Sensibilité	L'instrument distingue-t-il les variations pertinentes du phénomène ?	Si des niveaux très différents conduisent tous au même résultat, l'outil discrimine mal ces variations.

La fidélité ne signifie pas qu'une personne doit obtenir le même score pendant toute sa vie. Un enfant se développe ; un état anxieux peut évoluer ; une prise en charge peut modifier les symptômes. La stabilité attendue concerne d'abord la qualité de la mesure dans des conditions comparables et pour un phénomène suffisamment stable.

La sensibilité est utilisée ici au sens de finesse de discrimination des variations. Il faut distinguer ce sens du vocabulaire des performances d'un test de dépistage : le simple fait qu'un questionnaire attribue le même diagnostic à beaucoup de personnes ne permet pas d'identifier à lui seul le défaut psychométrique en cause.

Raisonner avec les trois critères

Un instrument peut être reproductible tout en ciblant mal le phénomène. Inversement, un outil pertinent mais trop variable fournit une mesure difficile à exploiter. Les qualités doivent donc être examinées ensemble.

03 · Repères historiques et portée des résultats

Les premières tentatives de tests d'intelligence apparaissent vers 1890, dans le développement de la psychologie moderne. Leur diffusion initiale est limitée. L'échelle métrique de l'intelligence de Binet, en 1905, donne une impulsion majeure au mouvement des tests. Les méthodes se diversifient ensuite et les démarches de construction et de validation deviennent plus élaborées.

Ces instruments répondent aussi à des besoins sociaux, notamment éducatifs : mieux repérer les difficultés et orienter les accompagnements. Leur utilisation dans les politiques scolaires et sociales explique les débats qu'ils suscitent. Une décision d'orientation peut avoir des conséquences importantes ; elle exige une interprétation prudente et une prise en compte des autres informations disponibles.

Sens du repère historique

L'objectif n'est pas de mémoriser une succession de tests : il est de comprendre que les outils sont construits pour des questions et des populations déterminées. Leur usage social ne doit pas transformer un résultat en destin individuel.

04 · L'examen psychologique : objectifs et déroulement

L'examen psychologique est une évaluation clinique approfondie du fonctionnement psychologique global de la personne, conduite par un psychologue. Il associe plusieurs instruments validés, entretiens et observations afin de répondre à une question clinique. Une batterie est un ensemble organisé d'épreuves, de tests et de questionnaires complémentaires.

Objectif	Ce que le bilan cherche à comprendre
Cognition et orientation	Niveau et profil cognitif ; difficultés ; ressources utiles à l'orientation scolaire ou professionnelle.
Aide au diagnostic	Nature des difficultés psychiques, symptômes présents et intensité.
Compréhension globale	Personnalité, vulnérabilités, ressources, qualité de vie et relations avec l'environnement.
Indication thérapeutique	Objectifs de soin et aspects à travailler dans l'accompagnement ou la psychothérapie.
Évaluation du changement	Dimensions qui évoluent, ou restent stables, pendant la prise en charge.
Pronostic	Hypothèses argumentées sur l'évolution possible, avec leurs limites.

Avant le bilan, la personne reçoit une information compréhensible sur son intérêt, ses objectifs et son contenu ; son accord éclairé est recherché. La demande peut venir d'elle-même, d'un proche, d'un médecin ou de l'école. Lorsque le demandeur est extérieur, son accord ne remplace pas l'adhésion du sujet évalué.

Le support évoque un à trois rendez-vous. Il s'agit d'une organisation possible, pas d'une règle fixe. Chez un enfant qui soutient difficilement son attention, plusieurs séances peuvent être nécessaires. Les modalités doivent rester compatibles avec les exigences des instruments utilisés.

Suivre les effets d'une prise en charge

Comparer l'intensité d'un symptôme au début puis plus tard peut aider à objectiver un changement. Mais l'intérêt d'un accompagnement ne se réduit pas à la disparition immédiate de la souffrance : la parole, le soutien et les ressources mobilisées font aussi partie de l'évaluation clinique.

Le pronostic n'est pas une prédiction certaine. Les conclusions articulent résultats, contexte, évolution et jugement clinique ; les outils soutiennent le raisonnement du professionnel.

05 · Cognition, personnalité et contexte

Évaluer le fonctionnement intellectuel aide à comprendre les résultats des autres épreuves. Comprendre une question, conserver une consigne en mémoire, organiser sa réponse ou lire un questionnaire suppose des capacités cognitives. Une difficulté cognitive peut donc modifier la manière de répondre, même lorsque l'outil vise les émotions ou la personnalité.

À l'inverse, les conditions affectives et relationnelles influencent l'expression des capacités. L'anxiété, la dépression, la fatigue, la motivation et la situation d'évaluation peuvent modifier les performances. On ne déduit pas automatiquement la cause d'une difficulté d'un score bas, ni d'un profil très dispersé.

Exemple clinique du cours

Une aisance relationnelle peut faire sous-estimer des difficultés cognitives. Il faut pouvoir reconnaître les capacités d'échange tout en adaptant les attentes, les explications et l'accompagnement aux difficultés objectivées. Une personne ne réussit pas nécessairement de la même façon dans tous les domaines.

Limite	Conséquence pour la lecture des résultats
État de la personne	Noter fatigue, anxiété, humeur, attention, motivation et fluctuations.
Compréhension et langage	Vérifier que les consignes et les questions ont été comprises.
Contexte	Relier les résultats aux conditions de passation et à la vie quotidienne.
Compétences du professionnel	La formation, la passation, la cotation et le temps d'analyse conditionnent la qualité du bilan.
Portée de l'instrument	Une mesure est une information parmi d'autres ; elle ne remplace pas une appréciation clinique globale.

L'entourage et l'environnement peuvent soutenir ou entraver l'expression des compétences. L'évaluation doit donc repérer les difficultés et les appuis disponibles. L'objectif pratique est d'adapter l'aide à la personne, sans surestimer ses capacités ni les nier.

06 · Les entretiens et le choix des méthodes

Entretien	Organisation	Intérêt et vigilance
Directif	Questions précises, ordre défini et réponses limitées.	Cible les informations ; peut soutenir des sujets jeunes ou ayant des difficultés cognitives, selon leurs capacités.
Semi-directif	Guide préparé, thèmes ou questions organisés, réponses plus libres.	Associe repères communs et développement de la parole ; adapté aux personnes à l'aise avec le langage.
Non directif	Parole libre à partir d'un thème ou d'une question initiale ; relances sans diriger le contenu.	Explore l'expérience singulière ; exige de pouvoir élaborer et organiser un discours.

Le choix ne dépend pas uniquement de l'âge chronologique : il tient compte des capacités de compréhension, du langage, de l'état psychique et de la question clinique. Soutenir une réponse ne signifie pas suggérer la réponse attendue.

Famille d'outils	Question principale	Exemples présentés
Tests de niveau et d'aptitudes	Comment la personne réalise-t-elle certaines tâches cognitives ?	WISC, K-ABC, WAIS ; vocabulaire de Mill Hill ; échelle de mémoire de Wechsler.
Personnalité	Quelles tendances de pensée, de comportement et de réaction retrouve-t-on ?	EPI, BFI/Big Five, NEO PI-R, MMPI.
Psychopathologie	Quels symptômes ou processus sont présents, et avec quelle intensité ?	SCL-90-R ; MINI ; Beck ; Hamilton ; mesures du perfectionnisme.
Méthodes complémentaires	Comment enrichir la compréhension clinique ?	Méthodes projectives, dessin, observation, registres et avis des proches.

Les outils doivent être choisis pour leur pertinence, leur validation et la population visée. Un questionnaire de personnalité trouvé en ligne n'est pas assimilable à un examen psychologique. La présence d'un sigle ou d'un score ne suffit pas à établir sa qualité.

07 · Le tout-petit : développement psychomoteur

Chez le tout-petit, les fonctions psychomotrices sont en développement. L'évaluation cherche à situer les acquisitions, identifier d'éventuelles difficultés et favoriser une intervention précoce. Elle explore des compétences adaptées à l'âge, plutôt que de demander les mêmes tâches qu'à un enfant plus grand.

L'échelle de Brunet-Lézine révisée illustre cette approche. Le tableau officiel organise les observations en quatre domaines : posture, coordination, langage et sociabilité. Il associe des situations d'observation et des questions aux parents. Ces modalités apportent des informations complémentaires.

Domaine	Ce que l'on observe	Exemples illustratifs du support
Posture	Contrôle du corps, positions et déplacements.	À 2 mois, soulèvement de la tête et des épaules en position ventrale ; à 14 mois, marche sur quelques pas.
Coordination	Organisation de l'action et utilisation des objets.	Suivi visuel, préhension ; à 14 mois, tour de deux cubes sur modèle et introduction d'une pastille dans un flacon.
Langage	Réactions à la voix, vocalisations, compréhension et premières productions.	À 2 mois, réponse à la voix par immobilisation ; plus tard, désignation d'objets et mots.
Sociabilité	Échanges, relation et participation aux interactions.	Sourire, intérêt pour les personnes ou objets ; à 14 mois, montrer du doigt ce qui intéresse.

Ces exemples servent à comprendre la logique de l'échelle. Ils ne sont ni un calendrier universel d'acquisition ni une grille autonome de diagnostic. L'appréciation d'un décalage repose sur l'ensemble du développement, les conditions d'observation et les règles de l'outil.

Place infirmière

Le cours insiste sur la formation avant l'utilisation d'un outil. Observer le développement, écouter les parents et transmettre des faits précis participent à l'évaluation ; cela ne se confond pas avec la réalisation improvisée d'un bilan spécialisé.

08 · Échelles de Wechsler : du score au profil

Les échelles de Wechsler sont des batteries composites : plusieurs subtests explorent différentes composantes du fonctionnement cognitif. Elles renseignent aussi sur la manière de faire face à une situation de performance : organisation, persévérance, compréhension des consignes et réactions aux difficultés.

Échelle citée	Public présenté dans le cours	Point de vigilance
WPPSI	Âge préscolaire ; l'oral évoque un début à 2 ans et 6 mois.	La tranche exacte dépend de l'édition et doit être vérifiée dans le manuel utilisé.
WISC-V	Enfants et adolescents.	Utiliser la version adaptée à l'âge et à la langue de la personne.
WAIS-IV	Adultes dans le support.	Les sous-tests et indices ne sont pas tous identiques entre éditions.

La durée moyenne donnée dans le cours est d'environ une heure trente. Ce repère ne constitue pas une durée maximale obligatoire. L'organisation dépend notamment de l'âge, de l'attention, de la fatigabilité et des modalités prévues pour la passation.

Indice ou domaine	Ce qu'il explore	Exemple de compréhension
ICV : compréhension verbale	Compréhension et mobilisation des connaissances verbales.	Vocabulaire, élaboration et compréhension de situations.
IMT : mémoire de travail	Maintien temporaire et utilisation d'informations pendant une tâche.	Garder une consigne ou des éléments à l'esprit pour agir.
IVT : vitesse de traitement	Rapidité et efficience sur certaines tâches simples.	Traiter des correspondances visuelles dans les conditions prévues.
IVS : visuo-spatial	Analyse et organisation des relations spatiales.	Organiser des formes ou reconstituer un ensemble.
IRF : raisonnement fluide	Recherche de relations et résolution de problèmes nouveaux.	Trouver une règle à partir d'éléments présentés.

Le support réunit ces indices pour présenter les grandes fonctions. Il faut éviter d'appliquer mécaniquement les cinq sigles à chaque version d'une échelle : l'organisation exacte dépend de la batterie. Les connaissances acquises éclairent la notion d'intelligence cristallisée, tandis que le raisonnement fluide met l'accent sur la

résolution de problèmes nouveaux ; cette distinction ne rend pas une performance indépendante de tout contexte.

QI total et hétérogénéité

Le cours insiste sur l'homogénéité relative des indices pour donner du sens à un résultat global. La question clinique est : dans quelle mesure une valeur unique rend-elle compte du fonctionnement observé ? Lorsque les performances sont très différentes d'un domaine à l'autre, le profil, les ressources et les difficultés doivent être explicités. La possibilité de calculer un chiffre et la pertinence de le résumer seul sont deux questions à distinguer.

> **Une prudence essentielle**
>
> Un profil homogène ou hétérogène ne suffit pas à établir l'origine d'une difficulté. On ne conclut pas à une cause génétique, organique ou psychique à partir de la seule dispersion des indices. Le résultat s'inscrit dans un bilan global.

Épreuves moins dépendantes du langage

Les matrices progressives de Raven et les tests de dominos, dont le D-2000 cité dans le support, explorent le facteur général d'intelligence à partir de matériel moins verbal. Ils peuvent être pertinents chez des enfants allophones. Le terme « a-culturel » du cours souligne la moindre dépendance au langage ; il ne dispense pas de considérer les apprentissages, la familiarité avec les tâches et les conditions de passation.

Chez une personne âgée, une batterie de mémoire ou une exploration plus étendue peut être proposée selon la question clinique. Une difficulté mnésique, une plainte cognitive et un résultat global ne sont pas des notions interchangeables.

09 · Évaluer la personnalité et ses dimensions

La personnalité renvoie aux façons habituelles de penser, de se comporter et de réagir, relativement stables dans le temps. Étudier des traits de personnalité n'équivaut pas à diagnostiquer un trouble de la personnalité. Le bilan peut explorer des aspects habituels du fonctionnement ainsi que d'éventuelles difficultés pathologiques.

Le modèle des cinq dimensions

Le NEO PI-R présente cinq grandes dimensions et six facettes par dimension. Une facette est une composante plus précise d'un domaine. Il ne s'agit pas de ranger toute la personne dans une catégorie unique.

Dimension	Sens général pour comprendre le cours
Névrosisme	Tendance à éprouver des émotions négatives, dont l'anxiété.
Agréabilité	Manière de se situer dans la coopération et les relations avec autrui.
Conscience	Organisation et engagement dans les activités.
Extraversion	Orientation vers les interactions et l'activité sociale.
Ouverture	Disposition à la curiosité et à l'exploration d'expériences ou d'idées.

L'EPI, le BFI et le MMPI font partie des autres instruments cités. Le MMPI, inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota, explore notamment des dimensions psychopathologiques, selon la version et le

public. Le support emploie certains intitulés historiques d'échelles : ils ne sont pas des étiquettes à appliquer directement à une personne.

Auto-évaluation, égosyntonie et insight

L'auto-évaluation suppose de comprendre les questions, d'observer son propre fonctionnement et de pouvoir en rendre compte. Une caractéristique égosyntonique est vécue comme accordée à soi ; la personne ne l'identifie pas nécessairement comme une difficulté. Elle peut néanmoins entraîner une souffrance ou des problèmes relationnels.

L'insight correspond à la conscience que la personne peut avoir de ses difficultés et de son fonctionnement. Il peut être limité ou fluctuant. Cela justifie de croiser les méthodes et les points de vue ; cela n'autorise pas à considérer systématiquement la parole du patient comme fausse.

> **À retenir**
>
> Un questionnaire renseigne sur les réponses d'une personne à un moment donné. L'interprétation recherche leur cohérence avec l'entretien, les observations et les autres instruments.

10 · Méthodes projectives et dessin

Les méthodes projectives présentent des stimuli ambigus et invitent à leur donner une signification ou à construire une histoire. Le cours les situe comme des moyens d'explorer des processus psychiques différents de ceux sollicités par un questionnaire d'auto-description. Leur administration et leur interprétation nécessitent une formation spécifique.

Méthode	Principe présenté dans le support
Rorschach	Réponses à des taches d'encre ; analyse selon un cadre de passation et de cotation.
TAT : Thematic Apperception Test	Histoires à partir d'images ambiguës ; le matériel comporte 31 images, avec une sélection adaptée à la passation.
CAT : Children's Apperception Test	Matériel pour l'enfant, avec dix planches de scènes animalières dans la version citée.
Patte-Noire	Choix de planches et construction d'histoires chez l'enfant.
Versions pour sujets âgés	Thématiques adaptées, notamment solitude ou maladie, dans les méthodes évoquées.

L'oral mentionne des systèmes de cotation, notamment les travaux d'Exner pour le Rorschach. Le point à retenir est l'existence d'une méthode d'analyse : il ne s'agit pas de commenter librement une image. Une réponse isolée ne constitue pas une preuve diagnostique ; l'intérêt et les limites dépendent de l'outil, des indicateurs et du cadre clinique.

Le dessin comme situation d'évaluation

Le clinicien peut considérer le thème, les personnages, le contexte, la taille, l'organisation de la feuille, le tracé, les détails et les réponses aux questions associées. Ces observations sont remises en lien avec l'âge, l'histoire et le contexte. Un détail graphique ne suffit pas à conclure à un trouble.

Épreuve citée	Consigne ou caractéristique utile
Bonhomme de Goodenough	Le cours attire l'attention sur l'influence des exercices scolaires répétés entre 3 et 6 ans ; prudence dans l'interprétation.
Arbre de Koch	Dessiner un arbre fruitier, puis un autre arbre et enfin un arbre imaginaire ; la consigne française évoquée exclut le sapin.
Dessin de famille	Dessiner la famille librement, puis répondre à des questions.
Dessin de Machover	Dessiner une personne, une personne de sexe opposé selon la consigne présentée, puis une personne idéale ; une série de questions complète l'épreuve.

Ces exemples montrent l'importance de la consigne et de l'entretien associé. Ils ne forment pas une méthode d'interprétation utilisable sans formation.

11 · Questionnaires, Beck et Conners

Qui répond et que cherche-t-on ?

Modalité	Répondant	Apport et limite
Auto-évaluation	La personne elle-même.	Accès à son expérience ; dépend de la compréhension, de la conscience des troubles et de la manière de se présenter.
Hétéro-évaluation	Parent, enseignant, proche ou clinicien selon l'outil.	Observation depuis un autre point de vue ; dépend du contexte et des attentes de l'observateur.

Les questionnaires peuvent explorer les troubles, leur intensité, les processus psychologiques qui y participent et leurs conséquences. Ils peuvent aussi concerner l'estime de soi, les relations, la qualité de vie et le désir de changement. Un même processus, comme le perfectionnisme, peut intervenir dans plusieurs troubles.

La régulation émotionnelle concerne la manière de reconnaître et de moduler ses émotions. Les croyances et schémas cognitifs orientent l'interprétation des situations ; les mécanismes défensifs participent à la manière de faire face aux tensions. Explorer ces processus aide à comprendre les difficultés au-delà d'une simple liste de symptômes.

L'oral rapproche le sentiment de ne pas pouvoir agir, la résignation acquise et le lieu de contrôle externe. Ces notions sont liées sans être identiques : le lieu de contrôle concerne l'attribution de ce qui arrive à ses propres actions ou à des facteurs extérieurs ; la résignation acquise renvoie au sentiment appris que ses actions ne changent plus l'issue. Le cours évoque aussi les facteurs salutogènes, qui soutiennent la santé, et pathogènes, qui participent aux difficultés. Ces éléments éclairent les ressources et les objectifs de soin.

Les troubles internalisés concernent notamment des difficultés tournées vers l'expérience interne, comme l'anxiété et la dépression. Les troubles externalisés se manifestent davantage dans les conduites observables et les interactions, par exemple l'agitation ou l'opposition. Ces regroupements n'épuisent pas la situation clinique.

Quelques instruments à distinguer

Instrument	Champ ou modalité
SCL-90-R	Inventaire large de symptômes psychologiques.
MINI	Entretien diagnostique structuré, cité parmi les instruments d'aide à l'évaluation.
Beck / Hamilton	Dépression : auto-évaluation pour Beck ; hétéro-évaluation pour Hamilton dans le cours.
Conners / Achenbach	Comportements et difficultés de l'enfant ou de l'adolescent ; plusieurs informateurs selon les versions.
CDI de Kovacs / RCMAS de Reynolds	Dépression et anxiété chez l'enfant pouvant répondre au questionnaire adapté.
GDS : Geriatric Depression Scale	Évaluation de la dépression chez la personne âgée.

Inventaire abrégé de Beck : comprendre la cotation

Le support présente le BDI-13, version courte à 13 items, à distinguer de la version à 21 items. Chaque item comporte quatre degrés cotés de 0 à 3. La somme des 13 réponses fournit un score de 0 à 39. Par exemple, 13 réponses cotées 1 donnent 13 points ; ce calcul n'établit pas à lui seul un diagnostic.

Attention aux seuils du support

La diapositive indique 0 à 4, puis 4 à 7, 8 à 15 et plus de 16. Le score 4 apparaît donc dans deux classes et le score 16 n'est pas classé explicitement. Ces intervalles ne constituent pas une grille clinique directement utilisable. Pour une passation réelle, suivre la version validée et ses règles de cotation ; ne pas mélanger les versions de Beck.

L'idée essentielle est de quantifier l'intensité des manifestations dépressives puis de confronter ce résultat à l'entretien. Une réponse préoccupante, notamment concernant les idées de mort ou de suicide, nécessite une appréciation clinique ; l'attention à cette réponse ne doit pas être remplacée par le seul total.

Conners : croiser les contextes

La page illustrée présente une échelle Conners 3 destinée au parent. Les réponses portent sur le dernier mois et utilisent une gradation de 0 à 3, de « pas du tout vrai » à « très vrai ». Le questionnaire explore des comportements ainsi que leur retentissement ; il comporte aussi des questions ouvertes. La valeur attribuée à un item n'est pas un diagnostic.

Selon la version, les informations peuvent venir du parent, de l'enseignant et du jeune lui-même. Le cours souligne l'intérêt de confronter leurs réponses. Un enfant peut se montrer plus agité dans une situation, à une heure donnée ou devant certaines tâches. Les attentes de l'adulte influencent également son appréciation.

Exemple de raisonnement

Un parent décrit une grande difficulté à terminer les devoirs en fin de journée, alors que l'enseignant observe une meilleure attention le matin. Il faut décrire les situations, les exigences et la fatigue, puis comparer les informations. Choisir d'emblée un observateur « qui a raison » ferait perdre une partie du sens clinique.

12 · Observation, registres et proches

L'observation permet de décrire les comportements en situation. On peut relever une fréquence, comme le nombre de fois où l'enfant jette un objet, ou une durée, comme le temps pendant lequel il reste engagé dans une activité. Le fait observé doit être distingué du jugement porté sur la personne.

Les registres organisent ces observations dans le temps. Chez l'enfant, un calendrier avec des symboles peut aider à repérer les épisodes d'énurésie ou d'autres comportements. L'objectif est de rendre la situation plus compréhensible et de soutenir la participation de l'enfant, en complément de la psychoéducation.

Chez l'adulte, l'auto-observation peut associer situation, pensées, émotions, intensité et comportements. Le fait d'observer et de noter peut aussi modifier la compréhension de ses réactions et participer au travail thérapeutique. L'outil sert donc à recueillir des informations et parfois à soutenir un changement.

À relever	Exemple de formulation utile
Contexte	Pendant les devoirs, après une journée d'école ; durée et tâche précisées.
Comportement	Se lève, interrompt ou abandonne l'activité : décrire les faits observables.
Fréquence ou durée	Nombre d'épisodes ou temps mesuré, avec une période d'observation identifiée.
Ressenti ou cognitions	Ce que la personne rapporte de ses pensées, émotions ou difficultés.
Point de vue complémentaire	Ce qu'observent les proches ou professionnels dans d'autres circonstances.

L'avis des proches est particulièrement utile lorsque la personne ne peut pas facilement rendre compte de son expérience : nourrisson, difficulté de langage, troubles cognitifs ou insight limité. Il enrichit l'évaluation sans effacer la parole ni les réactions du sujet. Les observations en famille, en classe ou en groupe éclairent la dépendance au contexte.

13 · Neuropsychologie et MMSE

La neuropsychologie étudie les relations entre fonctionnement cérébral, cognition et comportement ; le cours la présente à travers l'évaluation des troubles neurologiques. Les instruments peuvent explorer la perception, l'attention, la mémoire, le raisonnement et les fonctions exécutives à différents âges.

Le Mini Mental State Examination, MMSE ou MMS, est présenté comme un instrument de dépistage d'une possible détérioration cognitive. Il ne fournit pas, à lui seul, la cause d'une difficulté ni un diagnostic de maladie particulière. L'âge avancé ne signifie pas automatiquement une altération des capacités : le cours met explicitement en garde contre ce préjugé.

Domaine du MMSE présenté	Maximum	Ce qui est recherché
Orientation	10 points	Repères temporels et spatiaux.
Apprentissage	3 points	Enregistrement initial de trois éléments.
Attention et calcul	5 points	Maintien de l'attention dans la tâche standardisée.
Rappel	3 points	Restitution différée des éléments appris.

Domaine du MMSE présenté	Maximum	Ce qui est recherché
Langage	8 points	Dénomination, répétition, compréhension et activités de langage prévues.
Praxies constructives	1 point	Copie d'une figure selon la consigne.
Total	30 points	Synthèse de performances dans plusieurs domaines ; ne remplace pas l'analyse des réponses.

La page officielle présente la version consensuelle du GRECO, avec les consignes et les règles de cotation. Le score doit être calculé selon ce protocole. Ce cours explique les domaines ; il ne reproduit pas un formulaire de passation de remplacement.

Des conditions qui donnent du sens au résultat

Prévoir un lieu calme, un temps suffisant et une explication adaptée. Éviter de presser la personne et rester bienveillant, tout en respectant les consignes : encourager la participation ne signifie pas souffler une réponse ou entraîner au test. Noter les conditions susceptibles d'influencer les performances.

L'oral rappelle que l'anxiété et la dépression peuvent majorer le sentiment d'échec et les difficultés observées. L'interprétation prend en compte la situation globale ; un score se lit avec les observations, le fonctionnement quotidien et les autres données cliniques.

Place infirmière

Une utilisation peut s'inscrire dans le travail de l'équipe si le professionnel est formé et suit le cadre prévu. Ne pas réaliser le test à l'insu de l'équipe ou sans explication à la personne. Transmettre les réponses, les difficultés et les conditions observées, au-delà du total.

14 · Articuler l'évaluation et le soin

Deux approches complémentaires

Approche	Question principale	Ce qu'elle apporte
Catégorielle	Quels signes et critères permettent de reconnaître un trouble ?	Organisation diagnostique ; le cours renvoie au DSM et à la CIM.
Dimensionnelle	Avec quelle intensité une dimension ou un trouble se manifeste-t-il ?	Description graduée et suivi de l'évolution.

Repérer une catégorie et mesurer une intensité ne répond pas à toute la question clinique. Il faut aussi comprendre les processus psychiques, les relations, les ressources et les interactions avec l'environnement. La démarche associe outils structurés, entretien et observation.

La complémentarité des professionnels

Psychologues, médecins, infirmiers, psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes et éducateurs peuvent apporter des informations différentes. Cette complémentarité est particulièrement importante lorsque le langage, les capacités réflexives ou l'autonomie de la personne limitent l'auto-évaluation. Les proches peuvent éclairer le fonctionnement habituel et les variations.

Moment	Contribution infirmière dans le cadre de ses compétences
Avant	Comprendre la demande ; expliquer la démarche ; rechercher l'adhésion ; repérer les conditions défavorables.
Pendant	Respecter les consignes d'un outil lorsque l'on est formé ; observer attention, fatigue, compréhension et réactions.
Après	Tracer les résultats et les conditions ; distinguer faits et interprétations ; transmettre à l'équipe.
Dans le suivi	Mettre les observations en lien avec le quotidien et l'évolution ; contribuer à ajuster les objectifs de soin.

Situation d'application

Une personne obtient un résultat faible lors d'un repérage cognitif et paraît très anxieuse. L'infirmier décrit ses réponses et les conditions, recherche avec l'équipe ce qui a pu gêner la passation et transmet l'information au professionnel chargé de l'interprétation. Il ne conclut pas seul à une cause ni à un diagnostic sur le total.

La conclusion du bilan repose sur la compétence et le raisonnement du clinicien, soutenus par des instruments fiables. La psychométrie aide à comprendre et à accompagner une personne ; elle ne remplace ni la relation, ni l'histoire clinique, ni la coordination du soin.

15 · Pièges QCM

Confusion à éviter	Raisonnement correct
Standardisation = étalonnage	La première concerne les conditions ; le second, les références.
Test = bilan psychologique	Le test est un instrument ; le bilan est une démarche clinique globale.
Fidèle = valide	La reproductibilité ne garantit pas que l'on mesure la bonne dimension.
Fidélité = score immuable	Une évolution réelle ou un changement de contexte peut modifier le résultat.
Un chiffre résume toute la personne	Le profil, l'état, l'environnement et les ressources restent indispensables.
Un QI ou un profil explique à lui seul une cause	Un résultat isolé ne suffit pas à une conclusion étiologique.
Auto-évaluation = objectivité parfaite	Compréhension, insight et présentation de soi influencent les réponses.
Égosyntonique = sans souffrance	Une caractéristique vécue comme accordée à soi peut entraîner des difficultés.
Hétéro-évaluation = avis supérieur	Chaque observateur décrit un contexte et possède aussi des biais.
Conners = diagnostic automatique de TDAH	Le questionnaire apporte des informations à confronter à l'évaluation clinique.
Toutes les versions de Beck se cotent pareil	BDI-13 et versions à 21 items ne se confondent pas.
Le tableau de seuils ambigu peut être appliqué tel quel	Les bornes du support doivent être clarifiées ; utiliser le manuel de la version réelle.
MMSE = diagnostic de maladie d'Alzheimer	Le MMSE contribue au dépistage ; un résultat appelle une interprétation globale.
Personne âgée = troubles cognitifs	L'âge n'autorise pas ce préjugé.
Une réponse projective ou un dessin prouve un diagnostic	La réponse s'interprète dans un ensemble et dans un cadre professionnel formé.
L'accord d'un proche remplace celui du sujet	Informer et rechercher l'adhésion de la personne restent essentiels.
Un outil trouvé en ligne est nécessairement validé	La qualité dépend de sa construction, de sa validation et de son usage.

16 · Synthèse générale

La psychométrie construit et utilise des instruments standardisés et étalonnés pour situer des caractéristiques psychologiques. Les qualités fondamentales à distinguer sont la fidélité, la validité et la sensibilité aux variations. Un score est un indicateur, pas une définition exhaustive de la personne.

Le bilan psychologique répond à une question clinique par plusieurs méthodes complémentaires : entretiens, tests, questionnaires, méthodes projectives, dessin, observations et avis de l'entourage. Il prend en compte la cognition, la personnalité, les symptômes, les ressources et le contexte.

Les outils se choisissent selon l'âge, les capacités, le langage et la demande. Brunet-Lézine illustre le développement psychomoteur ; Wechsler, le profil cognitif ; les questionnaires de personnalité, les traits ; Beck et Conners, certaines manifestations et leur intensité ; le MMSE, le repérage de difficultés cognitives.

Une évaluation utile associe information et adhésion, formation aux outils, conditions de passation adaptées, analyse prudente et coopération. L'approche catégorielle aide à reconnaître les troubles ; l'approche dimensionnelle précise leur intensité. Dans tous les cas, les résultats prennent sens dans le raisonnement clinique et le projet de soin.

17 · Définitions et mots-clés

Terme ou sigle	Définition
01 · Psychométrie	Théorie et méthodologie de construction et d'utilisation des instruments de mesure des caractéristiques mentales.
02 · Caractéristique mentale	Dimension psychologique étudiée, par exemple connaissance, trait de personnalité, mémoire ou langage.
03 · Cognition	Ensemble des processus impliqués notamment dans l'attention, le langage, la mémoire et le raisonnement.
04 · Instrument psychométrique	Outil construit pour recueillir et interpréter des indicateurs psychologiques selon une méthode définie.
05 · Test mental	Situation standardisée donnant lieu à une observation et à une comparaison des réponses avec celles d'autres individus.
06 · Standardisation	Définition de conditions communes de passation, de consignes, de matériel et de cotation.
07 · Étalonnage	Construction de références permettant de situer un résultat individuel dans un groupe pertinent.
08 · Population de référence	Population par rapport à laquelle les performances d'une personne sont interprétées.
09 · Échantillon représentatif	Groupe choisi pour refléter les caractéristiques pertinentes de la population étudiée.
10 · Moyenne	Valeur centrale obtenue en divisant la somme des résultats par leur nombre.
11 · Écart-type	Indicateur de la dispersion des valeurs autour de leur moyenne.
12 · Fréquence relative	Part des observations appartenant à une catégorie ou à une classe de résultats.
13 · Classement quantitatif	Positionnement selon une valeur ou un niveau chiffré.
14 · Classement typologique	Regroupement selon un type ou une forme de fonctionnement.
15 · Fidélité	Qualité de stabilité et de reproductibilité de la mesure dans des conditions comparables.
16 · Validité	Adéquation entre ce que l'instrument mesure et le phénomène qu'il prétend évaluer.
17 · Sensibilité aux variations	Capacité d'un instrument à distinguer les variations pertinentes du phénomène étudié.

Terme ou sigle	Définition
18 · Examen psychologique	Évaluation clinique approfondie du fonctionnement global, menée par un psychologue avec plusieurs méthodes.
19 · Batterie	Ensemble organisé d'épreuves complémentaires.
20 · Subtest	Épreuve particulière à l'intérieur d'une batterie composite.
21 · Accord éclairé	Accord recherché après une information compréhensible sur la démarche, ses objectifs et son contenu.
22 · Adhésion	Participation et engagement de la personne dans la démarche proposée.
23 · Question clinique	Problème auquel l'évaluation cherche à apporter des éléments de réponse.
24 · Indication thérapeutique	Orientation du soin fondée sur les besoins et caractéristiques de la personne.
25 · Pronostic	Appréciation argumentée et incertaine de l'évolution possible d'une situation.
26 · Entretien directif	Entretien avec questions et réponses encadrées selon une organisation définie.
27 · Entretien semi-directif	Entretien guidé laissant une souplesse dans le développement des réponses.
28 · Entretien non directif	Entretien ouvert soutenu par des relances sans orientation imposée du contenu.
29 · Développement psychomoteur	Évolution des acquisitions motrices, de coordination, langagières et relationnelles du jeune enfant.
30 · Brunet-Lézine révisée	Échelle de développement du jeune enfant illustrant posture, coordination, langage et sociabilité.
31 · Aptitude	Capacité mise en jeu dans un domaine ou une catégorie de tâches.
32 · QI : quotient intellectuel	Indicateur de positionnement des performances intellectuelles par rapport à une référence.
33 · QIT : QI total	Score global d'une batterie d'intelligence, à interpréter avec les indices et le profil.
34 · Indice factoriel	Score regroupant des performances pour renseigner un domaine cognitif.
35 · Profil cognitif	Organisation des performances, ressources, points forts et difficultés dans plusieurs domaines.
36 · Homogénéité / hétérogénéité	Proximité relative ou dispersion des performances ; ne suffit pas à expliquer leur origine.

Terme ou sigle	Définition
37 · WPPSI	Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence : échelle pour l'âge préscolaire.
38 · WISC	Wechsler Intelligence Scale for Children : échelle pour l'enfant et l'adolescent.
39 · WAIS	Wechsler Adult Intelligence Scale : échelle pour l'adulte.
40 · K-ABC	Kaufman Assessment Battery for Children : batterie cognitive destinée à l'enfant.
41 · ICV	Indice de compréhension verbale : compréhension et mobilisation des connaissances verbales.
42 · IMT	Indice de mémoire de travail : maintien et utilisation temporaire des informations.
43 · IVT	Indice de vitesse de traitement : rapidité et efficience dans certaines tâches.
44 · IVS	Indice visuo-spatial : analyse et organisation des relations spatiales.
45 · IRF	Indice de raisonnement fluide : recherche de relations et résolution de problèmes nouveaux.
46 · Intelligence cristallisée	Mobilisation de connaissances et compétences acquises au cours de l'expérience.
47 · Facteur G	Facteur général utilisé pour décrire ce qui est commun à différentes performances intellectuelles.
48 · Allophone	Personne dont la langue première est différente de celle utilisée dans la situation considérée.
49 · Trouble mnésique	Difficulté touchant la mémoire.
50 · Personnalité	Ensemble des tendances relativement stables à penser, agir et réagir.
51 · Trait de personnalité	Dimension habituelle de fonctionnement, qui n'est pas en soi un trouble.
52 · Égosyntonie	Caractère d'un vécu ou fonctionnement ressenti comme accordé à soi.
53 · Insight	Capacité à reconnaître et comprendre certains aspects de son état et de ses difficultés.
54 · Auto-évaluation	Recueil des réponses de la personne sur son propre fonctionnement.
55 · Hétéro-évaluation	Évaluation par une autre personne, selon un outil et un cadre définis.
56 · NEO PI-R	Revised NEO Personality Inventory : inventaire des cinq dimensions de personnalité et de leurs facettes.

Terme ou sigle	Définition
57 · Facette	Sous-dimension précisant un domaine plus général de personnalité.
58 · MMPI	Minnesota Multiphasic Personality Inventory : inventaire de personnalité explorant notamment des dimensions psychopathologiques.
59 · EPI	Eysenck Personality Inventory : inventaire de personnalité cité dans le cours.
60 · BFI	Big Five Inventory : questionnaire associé au modèle des cinq grands traits.
61 · Méthode projective	Situation utilisant un matériel ambigu pour explorer l'élaboration de réponses dans un cadre clinique spécifique.
62 · Rorschach	Méthode utilisant des taches d'encre avec un cadre de passation et d'analyse.
63 · TAT	Thematic Apperception Test : élaboration d'histoires à partir de scènes ambiguës.
64 · CAT	Children's Apperception Test : méthode thématique destinée à l'enfant.
65 · Patte-Noire	Méthode projective pour l'enfant fondée sur des planches et des récits.
66 · Psychopathologie	Étude des troubles psychiques et des processus qui y participent.
67 · SCL-90-R	Symptom Checklist-90-Revised : inventaire de symptômes psychologiques.
68 · MINI	Mini International Neuropsychiatric Interview : entretien diagnostique structuré.
69 · BDI-13	Inventaire abrégé de dépression de Beck à 13 items cotés de 0 à 3, total de 0 à 39.
70 · Item	Unité d'un instrument : question, proposition ou tâche à laquelle une réponse est recueillie.
71 · Cotation	Attribution des valeurs prévues par les règles d'un instrument.
72 · Échelle de Hamilton	Instrument d'hétéro-évaluation de la dépression cité dans le support.
73 · Conners	Famille de questionnaires sur les comportements et difficultés, avec versions adaptées aux informateurs.
74 · Troubles internalisés	Difficultés exprimées notamment dans l'expérience interne, comme anxiété ou dépression.
75 · Troubles externalisés	Difficultés se manifestant davantage dans les conduites et interactions observables.
76 · GDS	Geriatric Depression Scale : échelle de dépression destinée aux personnes âgées.

Terme ou sigle	Définition
77 · Psychoéducation	Information et soutien aidant la personne à comprendre ses difficultés et à participer à leur prise en charge.
78 · Registre d'observation	Relevé organisé dans le temps de faits, situations, comportements ou expériences.
79 · Énurésie	Émissions d'urine involontaires dans une situation où le contrôle est attendu ; le cours illustre leur suivi par un registre.
80 · Cognition au sens de pensée	Pensée ou interprétation relevée dans une situation, notamment dans un registre d'auto-observation.
81 · Neuropsychologie	Étude des relations entre fonctionnement cérébral, cognition et comportement, notamment lors de troubles neurologiques.
82 · Fonctions exécutives	Processus d'organisation, de contrôle et d'adaptation de l'activité à un objectif.
83 · MMSE / MMS	Mini Mental State Examination : outil de repérage cognitif dont le total est coté sur 30.
84 · Orientation temporo-spatiale	Capacité à se repérer dans le temps et dans l'espace.
85 · Apprentissage / rappel	Enregistrement d'informations puis restitution après un délai ; deux temps à distinguer.
86 · Praxies constructives	Organisation d'une réalisation visuo-motrice, par exemple une copie de figure.
87 · Dépistage	Repérage d'une possible difficulté nécessitant une appréciation plus complète.
88 · Approche catégorielle	Démarche recherchant les signes et critères permettant de reconnaître une catégorie de trouble.
89 · Approche dimensionnelle	Démarche décrivant une dimension selon son intensité plutôt que par sa seule présence ou absence.
90 · DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders : classification diagnostique des troubles mentaux.
91 · CIM	Classification internationale des maladies.
92 · Travail multidisciplinaire	Mise en commun des observations et compétences de plusieurs professions pour comprendre et accompagner une situation.
93 · Névrosisme	Dimension de personnalité portant notamment sur la tendance à éprouver des émotions négatives.

Terme ou sigle	Définition
94 · Agréabilité	Dimension de personnalité concernant la coopération et la manière d'entrer en relation avec autrui.
95 · Conscience, dimension de personnalité	Dimension portant sur l'organisation et l'engagement dans les activités ; à distinguer de la conscience de ses troubles.
96 · Extraversion	Dimension de personnalité concernant l'orientation vers les interactions et l'activité sociale.
97 · Ouverture	Dimension de personnalité concernant la curiosité et l'exploration d'idées ou d'expériences.
98 · Régulation émotionnelle	Processus permettant de reconnaître et de moduler les émotions et leurs expressions.
99 · Schéma cognitif	Organisation des croyances et attentes orientant l'interprétation des situations.
100 · Mécanisme défensif	Mode de fonctionnement psychique participant à la manière de faire face aux tensions.
101 · Lieu ou locus de contrôle	Manière d'attribuer les événements à ses actions ou à des facteurs extérieurs ; le locus externe privilégie ces derniers.
102 · Résignation acquise	Sentiment appris que ses actions ne peuvent plus modifier l'issue d'une situation.
103 · Salutogène / pathogène	Qui soutient la santé / qui participe à l'apparition ou au maintien des difficultés.
104 · Perfectionnisme	Recherche d'exigences élevées et de maîtrise pouvant participer à des difficultés selon son intensité et son fonctionnement.
105 · Impulsivité	Tendance à agir rapidement avec une anticipation ou un contrôle limités de la réponse.